J. N. Lima Júnior, M. A. A.Santos Filho, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Infanticídio ou natimortalidade? O papel da perícia médico-legal na definição do caso

J. N. Lima Júnior[a,c,d*], M. A. A. Santos Filho[b,c,d]

[a]*NRPC-Oeiras – Núcleo Regional de Polícia Científica de Oeiras/PI*
[b]*IMLGV – Instituto de Medicina Legal Gerardo Vasconcelos, Teresina/PI*
[c]*DEPOC – Departamento de Polícia Científica*
[d]*PCPI – Polícia Civil do Estado do Piauí*
**Endereço de e-mail para correspondência: jnlj1992@outlook.com Tel.: +55-86-98177-0456.*

Resumo

A distinção entre natimortalidade e infanticídio representa um ponto crítico da medicina legal para a definição da materialidade criminal, sobretudo em contextos de gestação ocultada e parto não assistido. O presente trabalho relata o caso de um feto prematuro inumado após ocultação de gravidez, destacando a importância da aplicação rigorosa da docimásia hidrostática de Galeno associada à análise placentária e de reações vitais. No caso em tela, uma mulher buscou atendimento médico após relatar um abortamento domiciliar seguido do sepultamento do concepto no quintal de sua residência. A equipe pericial recuperou o feto, do sexo masculino e com idade gestacional estimada em 29 semanas (1.290 g), que ainda se encontrava ligado à placenta. O exame necroscópico constatou ausência de sinais de putrefação. A avaliação da placenta exibiu coágulos retroplacentários compatíveis com descolamento. Ao exame interno, os pulmões apresentavam aspecto "hepatizado" e a docimásia hidrostática de Galeno resultou negativa em todas as suas quatro fases clássicas, evidenciando a ausência de respiração extrauterina. Adicionalmente, foram identificadas petéquias subpleurais e subepicárdicas (manchas de Tardieu), além de hematomas subperiosteais no polo cefálico. Esses achados configuram reações vitais decorrentes de dinâmica circulatória ativa e esforço respiratório intrauterino, corroborando o diagnóstico de hipóxia e sofrimento fetal agudo no período periparto. A convergência dos achados permitiu concluir que a causa mortis foi anóxia intrauterina aguda secundária a descolamento prematuro de placenta. A condução técnica e integrada da necrópsia atestou com segurança a natimortalidade, descartando de forma contundente a hipótese criminal de infanticídio e reafirmando o papel indispensável da perícia médico-legal na elucidação dos fatos.

Palavras-chave: Docimásia pulmonar; Morte Fetal; Infanticídio; Autópsia; Medicina legal.

1. INTRODUÇÃO

A distinção entre natimortalidade, abortamento e morte de recém-nascido com vida extrauterina representa um dos pontos mais críticos da medicina legal, por poder definir a materialidade de um crime [1]. Historicamente, a comprovação da vitalidade pós-parto é considerada o maior de todos os desafios da prática médico-legal, sendo frequentemente denominada de *crucis peritorum* (a cruz dos peritos) [1,2]. Em cenários de gestação ocultada ou negada e de parto não assistido, essa diferenciação torna-se ainda mais complexa. Mães que ocultam a gravidez frequentemente entram em trabalho de parto sozinhas e, movidas pelo medo de julgamento ou punição legal, podem esconder o corpo do bebê, o que invariavelmente mimetiza a cena de um homicídio e levanta suspeitas por parte das autoridades [5]. Nesses contextos, a perícia médico-legal figura como elemento central na elucidação do fato e de suas implicações jurídicas.

Para solucionar esse dilema, a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno, descrita ainda no século XVII, permanece como um dos métodos mais tradicionais e utilizados na rotina pericial para inferir a ocorrência de respiração extrauterina [1,2]. O teste fundamenta-

-se na alteração da densidade pulmonar decorrente da respiração. Durante a vida intrauterina, o pulmão fetal apresenta aspecto compacto, carnoso e denso (sendo mais pesado que a água), afundando ao ser submerso. Contudo, com a primeira respiração autônoma e a consequente expansão alveolar, o volume do órgão aumenta acentuadamente e sua densidade diminui, permitindo a sua flutuação. O método é constituído por quatro fases clássicas de submersão, que avaliam desde o bloco visceral torácico intacto até fragmentos pulmonares isolados e comprimidos, tratando-se de técnica de execução simples, baixo custo e ampla aplicabilidade [1].

Estudos contemporâneos, entretanto, reconhecem que a determinação de infante nascido vivo deve resultar da análise integrada de múltiplos achados, mantendo-se a docimásia como ferramenta de grande utilidade apenas quando interpretada com rigor e ciente de suas limitações clínicas e técnicas [4]. A literatura forense internacional alerta que falsos-positivos podem ocorrer pela formação de gases de putrefação ou por manobras de reanimação cardiopulmonar que insuflam os pulmões artificialmente [1,2,4]. Por outro lado, falsos-negativos podem ser observados em bebês muito prematuros ou gravemente doentes, cujos pulmões podem não se expandir adequadamente mesmo após o nascimento com vida [4].

Diante deste cenário, o presente artigo tem como objetivo relatar o caso de um feto prematuro inumado após ocultação de gravidez e parto domiciliar desassistido, destacando a aplicação técnica rigorosa da docimásia hidrostática de Galeno aliada à avaliação de reações vitais e análise placentária. O estudo ilustra o papel imprescindível da medicina legal na elucidação da *causa mortis* e o consequente descarte seguro da hipótese criminal de infanticídio.

2. RELATO DO CASO

Mulher adulta procurou unidade hospitalar relatando episódio de abortamento domiciliar, seguido de sepultamento do concepto no quintal de sua residência. Informou ter tomado conhecimento da gestação apenas no dia anterior, após realização de ultrassonografia que evidenciou gestação única com idade gestacional de 28 semanas e 6 dias. A narrativa levantou suspeita pela equipe assistencial, sendo acionada a autoridade policial.

A equipe pericial realizou escavação no local indicado, sendo recuperado feto humano ainda ligado à placenta e recoberto por terra, conforme documentado na Fig. 1.



Figura 1. Aspecto inicial do feto. Nota-se o corpo encoberto por terra e ainda ligado à placenta. Fotografia registrada pelo autor.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para exame necroscópico. Ao exame externo, tratava-se de concepto do sexo masculino, com peso de 1.290 g e comprimento crânio-calcâneo de 37 cm, ainda ligado à placenta, esta com peso de 311 g. A idade gestacional estimada era de aproximadamente 29 semanas. Não foram identificadas malformações aparentes. O corpo encontrava-se recoberto por sedimento terroso, sem sinais de violência externa, exceto por discreta bossa sero-hemática em região occipital. O cadáver exibia rigidez completa e livores fixos, não apresentando, contudo, sinais iniciais de putrefação.

A placenta apresentava focos hemorrágicos e coágulos retroplacentários, compatíveis com áreas de descolamento, conforme ilustrado na Fig. 2.

Ao exame interno, a integridade do gradil costal estava preservada. Os pulmões mostravam-se de cor vermelho-escura, compactos, de consistência firme, sem crepitação ao manuseio e com ausência de desenho em mosaico alveolar (aspecto hepatizado). Observou-se congestão polivisceral difusa, além de petéquias subpleurais e subepicárdicas (manchas de Tardieu) (Fig. 3). No polo cefálico, identificaram-se dois hematomas subperiosteais medindo entre 2 e 3 cm de diâmetro, localizados em região occipital e parietal direita, além de focos hemorrágicos puntiformes distribuídos pelos ossos frontal e parietais, sem outras alterações relevantes.



Figura 2. Placenta em sua face materna, evidenciando-se coágulos retroplacentários. Fotografia registrada pelo autor.

Tendo em vista a ausência de gases putrefativos, foi realizada a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno, executada em suas quatro fases clássicas, evidenciando afundamento do bloco pulmonar e de seus fragmentos, sem liberação de bolhas gasosas à compressão (Fig. 4), resultado compatível com ausência de respiração extrauterina.

Diante do conjunto dos achados, concluiu-se pela ausência de sinais de nascimento com vida, sendo o concepto classificado como natimorto, com óbito decorrente de anóxia intrauterina aguda secundária a descolamento prematuro de placenta.

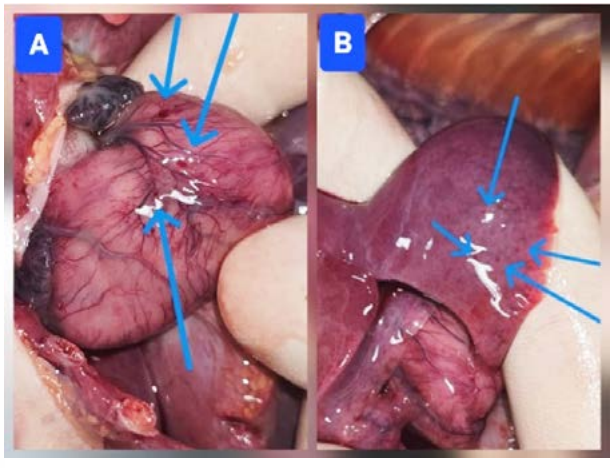


Figura 3. Petéquias intratorácicas. A) Petéquias subepicárdicas. B) Petéquias subpleurais.

Achados compatíveis com hipóxia e aumento da pressão venosa central no período agônico fetal, corroborando o diagnóstico de sofrimento fetal agudo. Fotografias registradas pelo autor.

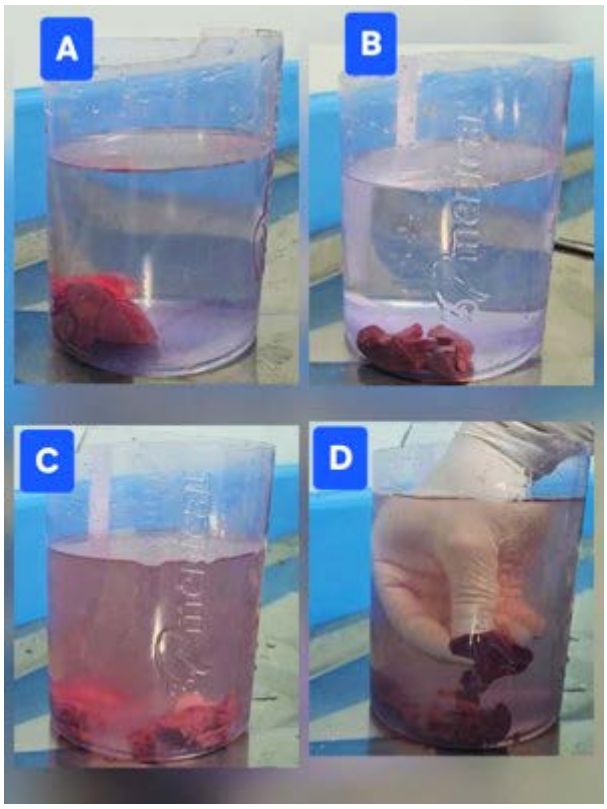


Figura 4. Docimásia pulmonar hidrostática de Galeno. A) 1ª fase negativa, com afundamento de todo o bloco visceral composto por pulmões, traqueia, laringe, língua, timo e coração. B) 2ª fase negativa, com manutenção dos pulmões no fundo após separação pelo hilo. C) 3ª fase negativa, com fragmentos pulmonares sem flutuação. D) 4ª fase negativa, sem liberação de bolhas à compressão dos fragmentos. O conjunto dos achados demonstra ausência de ar nos alvéolos e é compatível com ausência de respiração extrauterina. Fotografias registradas pelo autor.

3. DISCUSSÃO

A determinação de vida extrauterina constitui etapa fundamental na caracterização de infanticídio, sendo requisito essencial para a definição da materialidade do fato. Nesse contexto, a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno permanece como método clássico amplamente consolidado na prática médico-legal. Sua relevância prática decorre da simplicidade técnica e da possibilidade de execução com recursos mínimos, não demandando estrutura laboratorial sofisticada, o que a torna especialmente útil em contextos com limitações estruturais [1-4].

A confiabilidade da docimásia pulmonar está diretamente relacionada às condições em que é realizada. É reconhecido que a ausência de putrefação e de intervenções externas, como manobras de reanimação, reduz significativamente a possibilidade de resultados falso-positivos. Por outro lado, a literatura forense alerta para a possibilidade de resultados falso-nega-

tivos em recém-nascidos muito prematuros, cujos pulmões podem não expandir adequadamente mesmo havendo respiração pós-parto [4]. No presente caso, tratando-se de um feto prematuro de 29 semanas, o rigor diagnóstico foi garantido pela associação da docimásia hidrostática à Docimásia Óptica de Bouchut. O aspecto macroscópico liso, compacto e "hepatizado" dos pulmões, com ausência do desenho em mosaico alveolar, confirmou de forma consistente a ausência de qualquer expansão por ar extrauterino. Os pulmões apresentavam-se com desenvolvimento adequado e não havia sinais de putrefação.

Casos suspeitos de infanticídio frequentemente apresentam elevada complexidade diagnóstica, especialmente em contextos de ocultação de gestação e parto domiciliar, sendo comum a incerteza quanto à ocorrência de nascimento com vida e ocultação do cadáver por medo de implicações legais e sociais [5,6]. Nesse cenário, a avaliação pericial deve ser obrigatoriamente integrada.

Os achados do exame necroscópico são consistentes com morte fetal intrauterina decorrente de anóxia aguda, em contexto compatível com descolamento prematuro de placenta. A presença de focos hemorrágicos e coágulos retroplacentários indica separação parcial da decídua basal, alteração classicamente associada à interrupção abrupta do fluxo uteroplacentário e consequente instalação de hipóxia fetal [7,8].

Corroborando esse mecanismo, observou-se congestão polivisceral difusa e petéquias subpleurais e subepicárdicas (manchas de Tardieu). A presença dessas petéquias intratorácicas é justificada pelo quadro de asfixia intrauterina aguda. A fisiopatologia desse achado explica-se pelos movimentos respiratórios violentos (*gasping*) que o feto realiza *in utero* diante do sofrimento agudo; esse esforço gera uma intensa pressão intratorácica negativa que, combinada ao aumento súbito da pressão venosa central, resulta na ruptura dos capilares subserosos [8].

Adicionalmente, os achados cranianos, incluindo bossa sero-hemática e hematomas subperiosteais, configuram reações vitais, uma vez que dependem de circulação sanguínea ativa e gradiente de pressão intravascular para a sua formação. Tais elementos provam que o concepto se encontrava vivo, com atividade circulatória, no momento em que sofreu o trauma do parto expulsivo, sugerindo que a injúria hipóxica letal se desenrolou no período periparto agudo, afastando a hipótese de óbito intrauterino anterior ao parto [9].

Vale ressaltar que, em cenários de negação da gravidez e parto não assistido culminando em descolamento prematuro de placenta, a literatura contemporânea destaca a importância da investigação toxicológica. O uso de drogas de abuso por parte da gestante, como a cocaína e anfetaminas, possui forte imputabilidade na gênese do descolamento placentário, aumentando o risco dessa intercorrência em múltiplas vezes. A ausência de triagem toxicológica materna ou fetal no presente relato configura uma limitação, visto que poderia ter elucidado o fator desencadeante primário da patologia placentária [5-8].

Dessa forma, a convergência dos achados placentários, viscerais, cranianos e pulmonares demonstra que a morte ocorreu ainda no interior da cavidade uterina, em período próximo ao parto, por anóxia intrauterina aguda em cenário compatível com descolamento prematuro de placenta, sem indícios de violência externa. A análise técnico-científica integrada permitiu, com segurança, atestar a natimortalidade e afastar a materialidade do crime de infanticídio.

4. CONCLUSÕES

A necrópsia médico-legal, conduzida de forma criteriosa e integrada, foi determinante para a elucidação do caso. Ao confirmar a ocorrência de anóxia intrauterina aguda secundária ao descolamento prematuro de placenta, a perícia permitiu afastar a hipótese de nascimento com vida e, consequentemente, a materialidade do crime de infanticídio.

A docimásia pulmonar hidrostática de Galeno demonstrou elevado valor prático, destacando-se por sua simplicidade, baixo custo e ampla aplicabilidade. O caso ilustra que o método é capaz de fornecer elementos técnicos consistentes e seguros quando realizado em condições adequadas, notadamente na ausência de putrefação, e quando seus resultados são corroborados por outros parâmetros, como a inspeção visual pulmonar (docimásia óptica) e a análise de reações vitais.

Por fim, o presente relato reforça a importância da análise pericial multidisciplinar. Em cenários de negação de gravidez, partos desassistidos e ocultação de cadáver, a presunção inicial de crime pelas autoridades é alta. Fica evidente, portanto, o papel essencial da medicina legal na definição da materialidade dos fatos, evitando acusações infundadas e garantindo, em última instância, a justiça.

AGRADECIMENTOS

Ao Departamento de Polícia Científica da Polícia Civil do Piauí pelo incentivo à educação continuada e à publicação científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] França GV. *Medicina Legal*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017.

[2] Alfsen GC, Ellingsen CL, Hernæs L. «The child has lived and breathed.» Forensic examinations of newborns 1910-1912. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Dec 10;133(23-24):2498-501. English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.13.0898. PMID: 24326503.

[3] Obladen M. From Crime to Disease: Laws on Infanticide in the Modern Era. Neonatology. 2016;109(3):170-6. doi: 10.1159/000441275. Epub 2016 Jan 16. PMID: 26771523.

[4] Phillips B, Ong BB. "Was the Infant Born Alive?" A Review of Postmortem Techniques Used to Determine Live Birth In Cases of Suspected Neonaticide. Acad Forensic Pathol. 2018 Dec;8(4):874-893. doi: 10.1177/1925362118821476. Epub 2018 Dec 19. PMID: 31240078; PMCID: PMC6491538.

[5] Stenton S, Cohen MC. Assessment of neonaticide in the setting of concealed and denied pregnancies. Forensic Sci Med Pathol. 2020 Jun;16(2):226-233. doi: 10.1007/s12024-019-00212-4. Epub 2020 Feb 6. PMID: 32026385.

[6] Blanchot A, Antal MC, Ameline A, Gheddar L, Arbouche N, Raul JS, Kintz P. Pregnancy denial and unplanned home delivery: Considerations about fetal death causes and maternal drug use imputability. Forensic Sci Int. 2023 Jan;342:111538. doi: 10.1016/j.forsciint.2022.111538. Epub 2022 Dec 7. PMID: 36543017.

[7] Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Feb;90(2):140-9. doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01030.x. Epub 2010 Dec 7. PMID: 21241259.

[8] Bendon RW. Review of autopsies of stillborn infants with retroplacental hematoma or hemorrhage. Pediatr Dev Pathol. 2011 Jan-Feb;14(1):10-5. doi: 10.2350/10-03-0803-OA.1. Epub 2010 May 21. PMID: 20491541.

[9] Madea B, Doberentz E, Jackowski C. Vital reactions - An updated overview. Forensic Sci Int. 2019 Dec;305:110029. doi: 10.1016/j.forsciint.2019.110029. Epub 2019 Oct 31. PMID: 31726327.